Клинические рекомендации

Злокачественные новообразования полости рта

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C02.0** — Спинки языка **C02.1** — Боковой поверхности языка **C02.2** — Нижней поверхности языка **C02.3** — Передних 2/3 языка неуточненной части **C02.8** — Поражение языка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций **C02.9** — Языка неуточненной части **C03** — Злокачественное новообразование десны **C04** — Злокачественное новообразование дна полости рта **C05.0** — Твердого неба **C06** — Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 16.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/164_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика **5**

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы, анамнез и физикальное обследование 5

3.3 Цитологическое исследование и биопсия 5

3.4 КТ и МРТ лицевого черепа и шеи 5

3.5 Стадирование: узлы и отдалённые метастазы 5

4. Лечение 6

4.1 Тактика лечения по стадиям 6

4.2 Хирургическое лечение 6

4.3 Лучевая и химиолучевая терапия 7

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

5.1 Диспансерное наблюдение 8

5.2 Показания к госпитализации 8

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Раком слизистой оболочки полости рта называют злокачественную опухоль из плоскоклеточного эпителия слизистой оболочки щёк, нёба, дёсен, дна полости рта, языка; более 90% случаев — плоскоклеточный рак.
- Заподозрить рак следует при новообразовании, не поддающемся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**: безболезненном узелке, уплотнении, язве или трещине. Для верификации берут мазок-отпечаток, соскоб или биопсию.
- При T1–T2 N0 основным методом является операция; при местно-распространённых опухолях — операция с шейной лимфодиссекцией, затем ДЛТ или ХЛТ по неблагоприятным факторам. Операцию планируют, только если достижима резекция R0.
- **Лимфодиссекция по глубине инвазии опухоли**
  1. **менее 2 мм**: не показана;
  2. **2–4 мм**: индивидуально, возможна биопсия сторожевого узла;
  3. **более 4 мм**: ипсилатеральная селективная лимфодиссекция обязательна.
- Отступ от края инфильтрата при резекции — **1,5 см**; край препарата **менее 5 мм** от опухоли считается близким.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Рак слизистой оболочки полости рта — злокачественная опухоль, развивающаяся из элементов плоскоклеточного эпителия слизистой оболочки щёк, нёба, дёсен, дна ротовой полости, языка.

2.2 Этиология и эпидемиология

Этиологические факторы

1. курение, особенно в сочетании с крепким алкоголем, жевание смесей (орех бетель);
2. фоновые процессы: лейкоплакия, эритроплакия, хронические язвы и трещины губ, хейлиты;
3. хроническая инфекция в полости рта;
4. хроническая травматизация слизистой оболочки разрушенными зубами, корнями, некачественными протезами.

Распространённость — 6,52 на 100 000 населения; в 2021 г. в России зарегистрировано 9503 случая. Заболеваемость и смертность неуклонно растут.

2.3 Классификация

Более 90% злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта — плоскоклеточный рак, реже аденокарцинома из малых слюнных желёз и саркомы.

Степень дифференцировки: G1 — высокая, G2 — средняя, G3 — низкая.

Первичная опухоль (T) с учётом глубины инвазии (ГИ), TNM 8-е изд.

1. **Tis** — карцинома in situ
2. **T1** — **≤ 2 см** при ГИ **≤ 5 мм**
3. **T2** — **≤ 2 см** с ГИ **более 5 и ≤ 10 мм**; или **более 2 и ≤ 4 см** с ГИ **≤ 10 мм**
4. **T3** — **более 2 и ≤ 4 см** с ГИ **более 10 мм**; или **более 4 см** с ГИ **≤ 10 мм**
5. **T4a** — **более 4 см** с ГИ **более 10 мм**; прорастание только прилежащих тканей: кортикального слоя челюсти, верхнечелюстной пазухи, кожи лица
6. **T4b** — распространение на жевательный аппарат, крыловидные отростки, основание черепа и (или) охват сонной артерии

ГИ — глубина инвазии, а не общая толщина опухоли. Поверхностной эрозии кости или зубной лунки недостаточно для T4. Определения T2–T4a приведены в уточнённой редакции из текста КР.

Регионарные лимфатические узлы (cN)

1. **N1** — один узел на стороне поражения **менее 3 см**, без экстранодального распространения (ENE)
2. **N2** — один узел **более 3 и не более 6 см** (N2a), несколько на стороне поражения (N2b), с обеих или противоположной стороны (N2c) — до 6 см, ENE нет
3. **N3** — узел **более 6 см** без ENE (N3a) или метастаз любого размера с ENE (N3b)

Группировка по стадиям

Стадия	Сочетание T, N, M
0	Tis N0 M0
I	T1 N0 M0
II	T2 N0 M0
III	T1–T2 N1 M0; T3 N0–N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4a N0–N2 M0
IVB	любое T N3 M0; T4b любое N M0
IVC	любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

1. **начальный период** — безболезненные узелки, уплотнения, поверхностные язвы или трещины, не поддающиеся консервативному лечению; жжение или покалывание при еде
2. **развитой период** — боль практически в 100% случаев, иррадиирует в ухо, височную область; зловонный запах изо рта при вторичной инфекции и распаде
3. **запущенный период** — массивное разрушение окружающих тканей с вовлечением костей, преддверия рта, кожи, мышц

Формы роста: экзофитная (грибовидные, бляшкообразные разрастания с чёткими границами), эндофитная (язва с опухолевым валиком или инфильтрат без чётких границ) и смешанная.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: новообразование, не поддающееся консервативному лечению **2–3 недели**;
2. осмотра и пальпации образования, прилежащих тканей и регионарных узлов;
3. цитологического исследования соскоба, мазков, пунктата опухоли и узлов;
4. патолого-анатомического исследования биопсийного материала;
5. УЗИ полости рта и шеи, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ, фиброларингоскопии по показаниям.

3.2 Жалобы, анамнез и физикальное обследование

Перед лечением собирают жалобы и анамнез; осмотр включает бимануальную пальпацию очага и регионарных узлов и оценку нутритивного статуса. Перед лечением выполняют общий и биохимический анализы крови, коагулограмму, общий анализ мочи.

3.3 Цитологическое исследование и биопсия

При подозрении на рак до лечения берут мазки-отпечатки, соскоб или биопсию с поверхности эрозий, язв, трещин; уплотнения без изъязвления пунктируют тонкой иглой. При неясном результате цитологии выполняют биопсию с патолого-анатомическим и иммуногистохимическим исследованием.

1. **опухоль верифицирована** — определить гистологический тип и степень дифференцировки
2. **сомнительный результат** — обязательная повторная биопсия в объёме, достаточном для иммуногистохимии
3. **отрицательный результат** — повторная биопсия при убедительных клинических или рентгенологических признаках рака

3.4 КТ и МРТ лицевого черепа и шеи

Всем пациентам с верифицированным раком для оценки распространённости выполняют КТ и (или) МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием (от основания черепа до верхней апертуры грудной клетки).

1. **МРТ** — предпочтительна при симптомах вовлечения черепных нервов — оценка периневральной инвазии
2. **КТ** — информативнее для оценки деструкции кортикального слоя кости
3. **УЗИ тканей полости рта** — при артефактах от металлоконструкций зубных протезов

3.5 Стадирование: узлы и отдалённые метастазы

1. **УЗИ лимфатических узлов шеи** — всем; при признаках метастазов — биопсия узла под контролем УЗИ
2. **КТ органов грудной полости** — всем до лечения; при невозможности — рентгенография лёгких
3. **ПЭТ-КТ с ФДГ или КТ грудной и брюшной полостей** — при III–IV стадии или T1–T2 с N1 и более
4. **эзофагогастродуоденоскопия, фиброларингоскопия** — по показаниям

При III–IV стадии или T1–T2 с N1 и более и клиническом подозрении на метастазы в головной мозг выполняют МРТ головного мозга с контрастированием, при невозможности — КТ.

Для планирования лучевой терапии выполняют МРТ мягких тканей головы и шеи. Эффект ЛТ/ХЛТ оценивают по ПЭТ всего тела или МРТ с контрастированием **через 2–3 месяца** после окончания лечения. При нерезектабельной опухоли определяют экспрессию PD-L1 (TPS, CPS).

4. Лечение

4.1 Тактика лечения по стадиям

На первом этапе онколог, специализирующийся на опухолях головы и шеи

1. получает достаточный биопсийный материал;
2. оценивает распространённость опухоли и функциональное состояние;
3. исключает вторые опухоли полости рта и ротоглотки;
4. определяет хирургические опции.

Операция возможна, только если достижима резекция R0; лимфодиссекцию и реконструктивный этап планируют заранее.

Тактика по стадиям

Стадия	Лечение
T1–T2 N0	операция — основной метод; при противопоказаниях или отказе — ДЛТ или брахитерапия по радикальной программе
T3–T4a N0 M0	операция с ипсилатеральной или билатеральной (при центральном расположении или переходе за среднюю линию) шейной лимфодиссекцией
T1–T4a N1–N3 M0	операция с ипсилатеральной или билатеральной лимфодиссекцией; при противопоказаниях или отказе — ХЛТ
T4b, нерезектабельные N+ или противопоказания к операции	по ECOG: 0–1 — ХЛТ или индукционная ХТ с последующей ДЛТ/ХЛТ и решением вопроса об операции; 2 — ДЛТ ± ХТ; 3 — паллиативная ДЛТ, монохимиотерапия или паллиативная помощь

Тактика после операции по неблагоприятным прогностическим факторам (НПФ)

1. **pN0 без НПФ** — динамическое наблюдение
2. **pN1 без других НПФ** — реоперация до лимфодиссекции I–V уровней или послеоперационная ДЛТ
3. **pT3–4, периневральная, периваскулярная, перилимфатическая инвазия, pN2–3a** — послеоперационная ДЛТ; при 2 и более НПФ — рассмотреть ХЛТ
4. **только R1** — перерезекция, при невозможности — конкурентная ХЛТ
5. **ENE+ (pN3b)** — конкурентная ХЛТ

При местно-распространённой опухоли и угрозе кровотечения оценивают риск (изъязвление, полость, близость ветвей сонной артерии, незаживающая рана, состоявшееся кровотечение); при наличии риска выполняют ангиографию и суперселективную эмболизацию сосудов опухоли.

4.2 Хирургическое лечение

Признаки нерезектабельности (T4b)

1. вовлечение крыловидной мышцы или крылонёбной ямки: тризм, периферическая нейропатия;
2. распространение на основание черепа, в овальное отверстие;
3. распространение на верхние отделы и латеральную стенку носоглотки, устье слуховой трубы;
4. массивные метастазы на шее с распадом и вовлечением кожи;
5. распространение на медиастинальные узлы, превертебральную фасцию, шейный отдел позвоночника, магистральные сосуды; внутрикожные метастазы.

Ни один признак не является абсолютным противопоказанием: решающим служит возможность резекции R0.

Опухоль удаляют единым блоком с адекватным отступом; объём планируют по осмотру и лучевым исследованиям.

Резекция нижней челюсти

1. краевая или сегментарная — при инфильтрации альвеолярного края, неподвижности опухоли относительно челюсти, врастании по данным лучевых методов;
2. окончательный объём определяют интраоперационно;
3. при поражении канала нижнечелюстного нерва — сегментарная резекция.

Края резекции

1. рекомендуемый отступ от инфильтрата: **1,5 см**, не всегда выполним из-за магистральных сосудов;
2. чистый край: **5 мм и более**;
3. близкий край: **менее 5 мм**;
4. положительный край: опухолевые клетки по краю препарата.

Лимфодиссекция

1. **cN0** — селективная шейная лимфодиссекция I–III уровней
2. **cN+** — шейная лимфодиссекция I–V уровней: ипсилатеральная, при контралатеральном метастазе или срединной опухоли — билатеральная
3. **N2c** — радикальная лимфаденэктомия с двух сторон (I–V)

Главный предиктор метастазирования — глубина инвазии: **менее 2 мм** — лимфодиссекция не показана, **2–4 мм** — индивидуально или биопсия сторожевого узла, **более 4 мм** — ипсилатеральная селективная лимфодиссекция обязательна.

Биопсия сторожевого лимфатического узла — альтернатива селективной лимфодиссекции при T1–T2 с клинически неопределяемыми метастазами; эффективность метода — 95%. При метастазе в сторожевом узле выполняется лимфодиссекция I–V уровней, при его отсутствии лимфодиссекция не показана.

4.3 Лучевая и химиолучевая терапия

Самостоятельная ДЛТ (противопоказания к операции, нерезектабельность, отказ)

1. первичный очаг и клинически определяемые метастазы: 66–70 Гр по 2,0–2,2 Гр, 6–7 недель;
2. локорегионарная область с регионарными узлами: 46–54 Гр по 1,8–2,0 Гр;
3. при T1–T2 N0 альтернатива ДЛТ — брахитерапия в самостоятельном варианте.

При местно-распространённых опухолях без возможности операции проводится ХЛТ: ЛТ в тех же дозах с цисплатином 100 мг/м² на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни либо еженедельно 40 мг/м²; суммарно 300 мг/м². При противопоказаниях к препаратам платины (СКФ менее 50–60 мл/мин, возраст старше 65 лет, ECOG более 1, тяжёлая сопутствующая патология) их заменяют цетуксимабом.

Послеоперационная ДЛТ показана при pT3–4 и N2–3, а также при pT1–2 N0–1 с неблагоприятными признаками; интервал после операции — **менее 6 недель**, не более 3 месяцев. Доза на ложе опухоли и метастазов — не менее 60 Гр при R0 и 66 Гр при R+. Послеоперационная ХЛТ проводится при ENE+ или R1/R2; при ENE− и R0 её рассматривают при двух и более неблагоприятных факторах.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

УЗИ лимфатических узлов шеи с двух сторон

1. первый год: **каждые 3 месяца**;
2. второй год: **каждые 3–6 месяцев**;
3. 3–5-й год: **1 раз в 6 месяцев**;
4. после 5 лет: **1 раз в год**.

Другие исследования

1. КТ органов грудной полости — **каждые 12 месяцев**;
2. УЗИ органов брюшной полости — по той же схеме, что УЗИ шеи;
3. КТ или МРТ головы и шеи — по клиническим показаниям и при невозможности адекватного осмотра;
4. при подозрении на рецидив — ПЭТ-КТ или КТ грудной и брюшной полостей.

Физикальный осмотр: во 2-й год — **каждые 2–6 месяцев**, на 3–5-й год — **1 раз в 4–8 месяцев**, после 5 лет — ежегодно или при жалобах. Тиреотропный гормон после облучения шеи — **каждые 6–12 месяцев**.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания;
2. осложнения лечения: хирургического, лучевого, лекарственного.

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства;
2. специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре.

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли;
2. глубина инвазии;
3. степень дифференцировки;
4. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
5. статус регионарных узлов (метастазы на шее вдвое снижают выживаемость), экстранодальное распространение;
6. статус краёв резекции.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Злокачественные новообразования полости рта»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 16.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	164_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Российское общество клинической онкологии; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице символа T для T2, T3 и T4a приведены по два определения: исходное и с пометкой «изменить на» — стадирование по глубине инвазии в тексте неоднозначно. На странице — уточнённая редакция.
- Периодичность физикального осмотра в первый год после лечения в разделе 5 указана как «каждые 13 мес» (вероятно, 1–3 месяца); УЗИ шеи в разделе 2.5.3 — каждые 3 месяца.